
PRESENTATION
by Group 3
HOSPITAL


Group 3
ขอเชิญร่วมสัมมนา
จากอาการปวด สู่การป้องกัน:
การจัดการ MSDs อย่างเป็นระบบ
เพราะสุขภาพที่ดี... เริ่มได้จากการป้องกัน
ความหมาย ของ MSDs (Musculoskeletal Disorders)
ปัจจัยเสี่ยง/ อาการ
ผลกระทบ
แนวทางการ จัดการ
วันที่ 7 ตุลาคม 2569
เวลา 13.00 - 14.30 น.
ห้อง 508 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สุขภาพดี เริ่มที่เรา


20:43:10:17

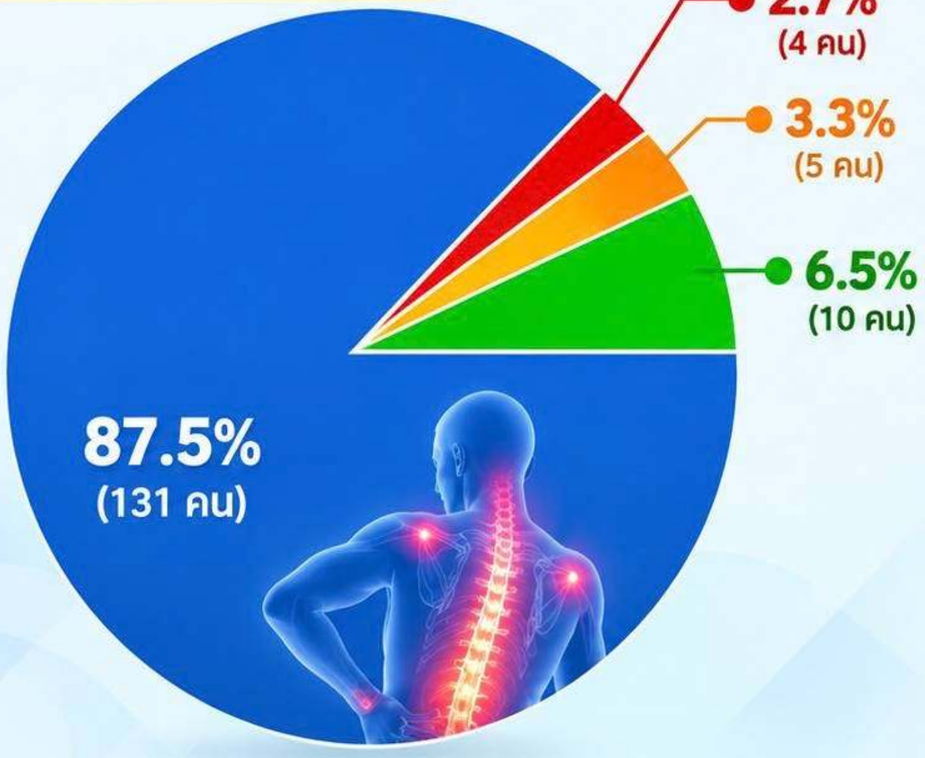
survey results



จากการทำแบบสอบถาม
ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน
ของพยาบาลห้องผ่าตัด จำนวน 150 คน



คำตอบทั้งหมด 150 คน



1 ระบบกล้ามเนื้อ / กระดูก และระบบหลอดเลือด

87.5% (131 คน)

เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ไหล่ดีด โรครองช้ำ นิ้วล็อก เส้นเลือดขอด ขาบวมจากการยืนนาน หน้ามืดหรือวูบ



2 ระบบทางเดินปัสสาวะ

2.7% (4 คน)

เช่น ทางเดินปัสสาวะอักเสบ นิ่ว



3 ระบบทางเดินหายใจ

3.3% (5 คน)

เช่น ไอ จาม อาการแพ้ หรือระคายเคือง จากการสูดดมควัน/สารเคมี



4 ระบบทางเดินอาหาร

6.5% (10 คน)

เช่น กระเพาะอาหารอักเสบ กรดไหลย้อน



1 ความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง



1.1 ความหมายของ MSDs





1.2 ความหมายของการยศาสตร์ (Ergonomics)





1.3 ความหมายของ Safe Patient Handling and Mobility











2 ประเภทและอาการของ MSDs



2.1 อาการปวดหลังส่วนล่าง



2.2 อาการปวดคอ



2.3 อาการปวดไหล่



2.4 กล้ามเนื้อเคล็ดหรือเอ็นอักเสบ



2.5 กลุ่มอาการกดทับเส้นประสาท



2.6 อาการเตือนที่ควรให้ความสำคัญ




Visit the Website

3 ปัญหาและปัจจัยเสี่ยง ของ MSDs



3.1 ปัจจัยด้านบุคคล



3.2 ปัจจัยด้านงานและสิ่งแวดล้อม



3.3 ปัจจัยด้านอุปกรณ์และการจัดพื้นที่



3.4 ปัจจัยด้านองค์กรและการบริหารจัดการ



สาเหตุตัวร้าย



4 ผลกระทบของ MSDs

เมื่อร่างกายต้องทำงานหนัก...ผลกระทบอาจมากกว่าที่คิด



ดูแลร่างกายวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

4.1 ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย



4.2 ผลกระทบต่อสุขภาพจิต



4.3 ผลกระทบต่อการทำงาน



4.4 ผลกระทบต่อองค์กร



4.5 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ



สุขภาพดี งานดี องค์กรยั่งยืน

5 แนวทางการจัดการ MSDs อย่างเป็นระบบ

SYSTEMATIC APPROACH TO MSDs MANAGEMENT



5.1 หลักการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

(Work Practices & Body Mechanics)



5.2 การปรับปรุงสภาพการทำงาน

(Ergonomic (nterventions)



5.3 การบริหารจัดการเวลาและทีมงาน

(Task Management)



5.4 การจัดการเชิงระบบและองค์กร

(Administrative Controls)



5.5 การส่งเสริมสุขภาพและการสร้างความตระหนั

(Education & Health Promotio



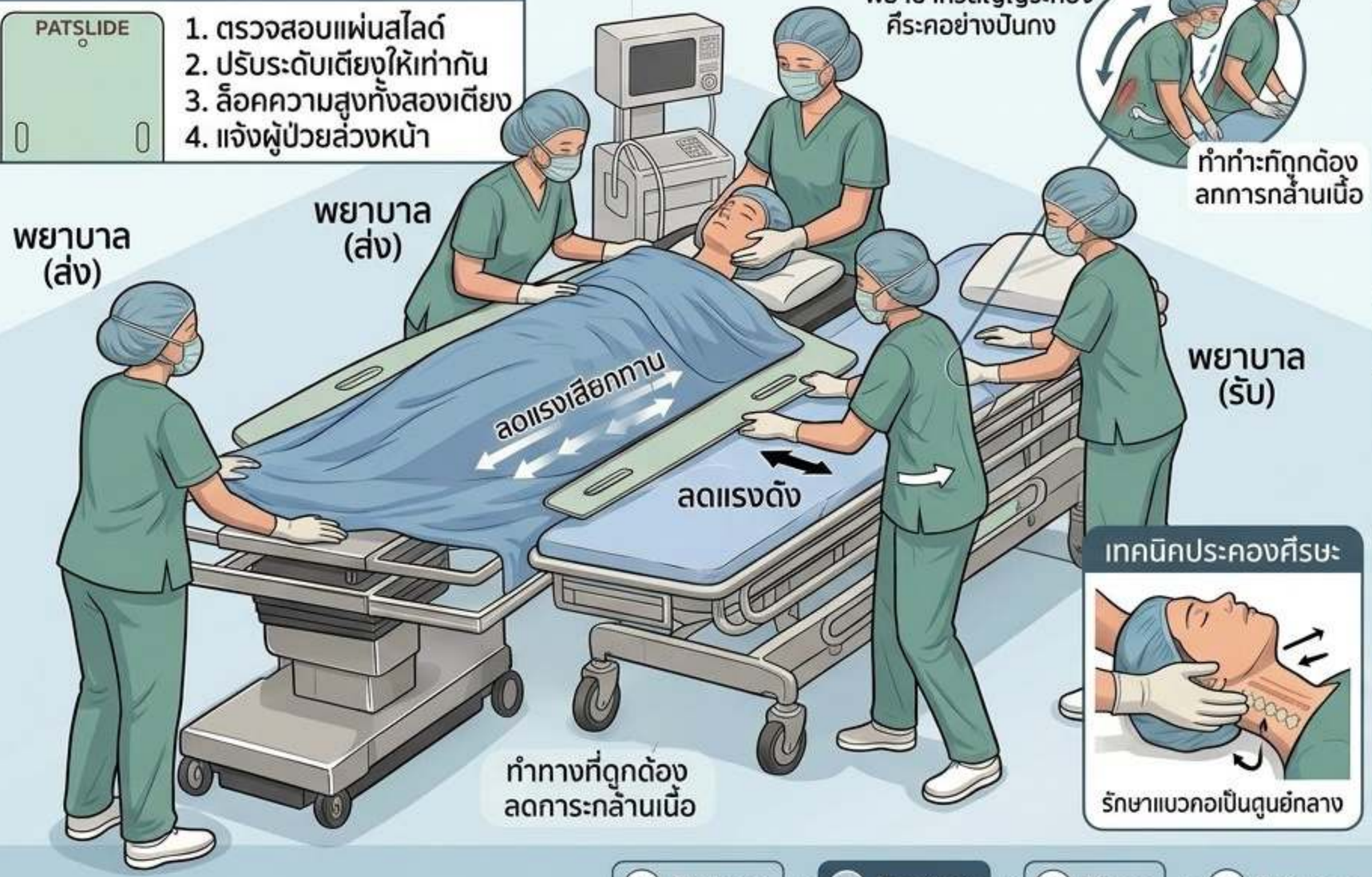
HEALTHY WORKFORCE SAFER CARE SUSTAINABLE TOMORROW

สุขภาพดี งานปลอดภัย ใส่ใจอย่างยั่งยื

แนวทางการใช้ PATSLIDE
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยในห้องผ่าตัด

ก่อนการเคลื่อนย้าย

1. ตรวจสอบแผ่นสไลด์
2. ปรับระดับเตียงให้เท่ากัน
3. ล็อคความสูงทั้งสองเตียง
4. แจ้งผู้ป่วยล่วงหน้า





เทคนิคประคองศีรษะ

รักษาแบวคอเป็นศูนย์กลาง

ผลลัพธ์: ลดอาการ MSDs

เคลื่อนย้ายแบบเดิม (Straining Move)	เคลื่อนย้ายด้วย PATSLIDE
	

ผลลัพธ์: ลดอาการ MSDs

เคลื่อนย้ายแบบเดิม (Straining Move)	เคลื่อนย้ายด้วย PATSLIDE
	
• เคลื่อนย้ายแบบตั้งเดิม • กาการปวดเปียยเรื้อรัง • การมาดเข็บของกล้านเนื้อ • กรวการเคลื่อนข้าย • ลีระเบดิมทบ ปลายเท้า	• เคลื่อนข้ายด้วอดุปกรณ์ • ลดแรงกดของกล้านเนื้อ • สุขกาพร้ายทายดิดิ้น

1 Prepare → 2 Position → 3 Move → 4 Remove

Copyright 2024 Surgical Innovations OR Safe Guides

เปรียบเทียบเสื้อกันรังสีแต่ละประเภท

น้ำหนักต่างกัน จุดรับน้ำหนัก...ก็ไม่เหมือนกัน

1 Frontal Apron
แบบชั้นเดียวคลุมด้านหน้า



KG น้ำหนักโดยประมาณ **3.5 – 5.0 กก.**



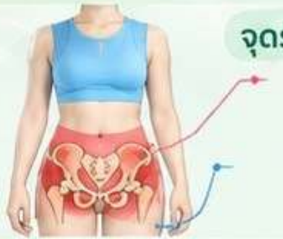
จุดรับน้ำหนักหลัก

ไหล่และ
กระดูกสันหลัง
ส่วนบน

2 Vest & Skirt
แบบเสื้อและกระโปรงแยกชิ้น



KG น้ำหนักโดยประมาณ **5.5 – 8.0 กก.**



จุดรับน้ำหนักหลัก

สะโพก/กระดูกเชิงกราน
60%

ไหล่
40%

3 Wraparound Apron
แบบพันรอบตัว



KG น้ำหนักโดยประมาณ **5.5 – 8.0 กก.**



จุดรับน้ำหนักหลัก

กระจายรอบลำตัว
แต่ยังมีภาระที่
ไหล่และหลังส่วนบน

สรุปสั้นๆ

- **Frontal Apron** 3.5 – 5.0 กก.
  รับน้ำหนักที่ไหล่และหลังส่วนบน
- **Vest & Skirt** 5.5 – 8.0 กก.
  สะโพก/เชิงกราน 60%
  ไหล่ 40%
- **Wraparound Apron** 5.5 – 8.0 กก.
  กระจายรอบลำตัว แต่ยังมีภาระที่
  ไหล่และหลังส่วนบน

เลือกให้เหมาะสม
เพื่อความปลอดภัย
และสุขภาพที่ดีในระยะยาว



คู่มือการเลือกขนาดเสื้อกันรังสีอย่างละเอียด (Lead Apron Sizing Guide)

4 ขั้นตอน



1 Overlap (การซ้อนเกยกัน)

แผ่นหน้าเกยกันอย่างน้อย 10-15 ซม.
เพื่อป้องกันรังสี 360 องศา



2 Chest & Waist (รอบอกและรอบเอว)

กระชับพอดีตัว ไม่หลวมเกินไป



3 Length (ความยาว)

ความยาวคลุมถึงระดับเหนือหัวเข่า
เพื่อปกป้องอวัยวะสืบพันธุ์และไขกระดูก



4 Shoulder & Armhole (ไหล่และวงแขน)

กระจายน้ำหนักได้ดี ไม่รั้งไหล่
เคลื่อนไหวแขนได้สะดวก



putting on shops





การแยกชนิดรองเท้า ที่ได้มาตรฐานในห้องผ่าตัด

1. รองเท้าสำหรับสวมใส่ภายในห้องผ่าตัด (โซนปลอดเชื้อ)



- รองรับน้ำหนักได้ดี (Ergonomic Support)
- แบบหัวปิด ป้องกันเลือดกระเด็น (Closed-toe, Blood Splash Protection)
- วัสดุทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย (Easy to Clean & Sterilize)
- สีต่างๆ (Multicolor Options)

เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัยภายในพื้นที่ปลอดเชื้อ

2. รองเท้าสีดาชดำสำหรับใช้ภายนอกห้องผ่าตัด



- ห้ามใช้ภายในโซนปลอดเชื้อ (Do Not Use in Sterile Zone)
- พื้นแบน (Flat Sole)
- ติดต่อภายนอก / รับคนไข้หน้าห้อง (Exterior Contact / Patient Reception)
- ใช้สำหรับออกจากพื้นที่ห้องผ่าตัด (Exit O.R. Area)

5.2

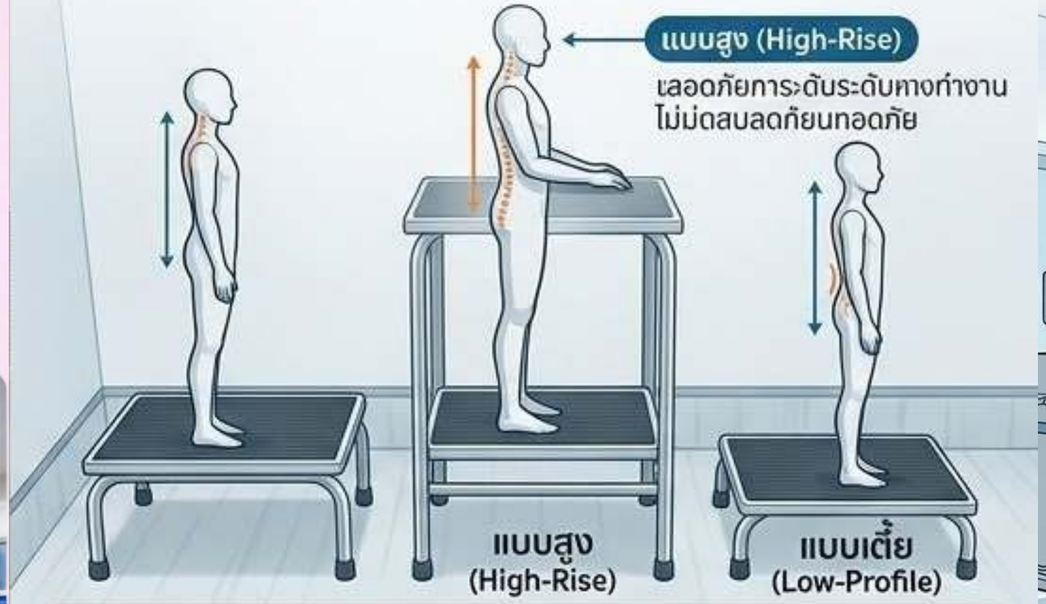
การปรับปรุงสภาพการทำงาน

(Ergonomic (nterventions)



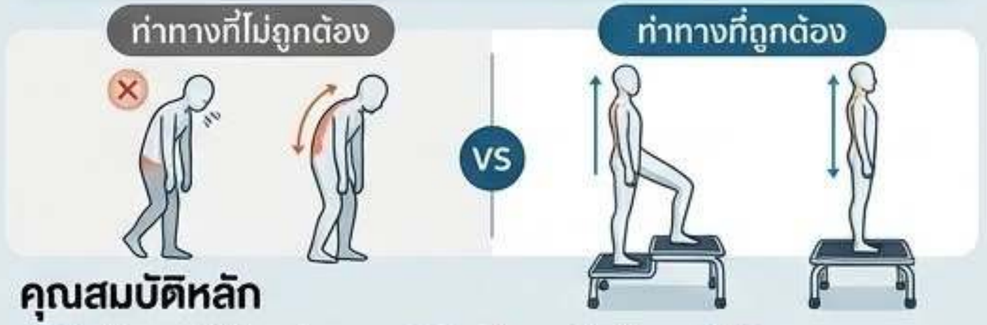
ที่รองยืนปรับระดับเพื่อสรีระที่เหมาะสม

เลือกความสูงที่ใช่เพื่อท่าทางที่ถูกต้อง ลดความเมื่อยล้า



ไม่เงยจนเกินไป: ลดความเครียดที่คอและบ่า

ไม่ก้มจนเกินไป: ลดแรงกดที่หลังและเอว



คุณสมบัติหลัก

- โครงเหล็กโครเมียม แข็งแรง
- พื้นยางกันลื่น Anti-Slip
- ยางรองขา Floor Protectors

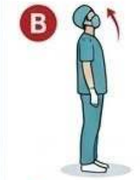
โคมยาอต
www.thaivnarw/thai.com
098-456-6770

ระบบที่รองยืนศัลยกรรมแบบปรับระดับความสูง 3 ระดับ





ยืนก้มมากเกินไป



ยืนเงยมากเกินไป



ทัศนวิสัยและการยืนที่เหมาะสม



ระบบที่รองยืนศัลยกรรม 3 ระดับ

- โครงสแตนเลสเกรดการแพทย์
- พื้นยางระแนงกันลื่น
- ฐานมั่งคง ทนทาน

5.3 การบริหารจัดการงานและทีมงาน (Task Management)



1 Plan



2 Break





3 Rotate





4 Share



ผลลัพธ์



Reference

1. Koyuncu A, Kaya K, Kaya O, Yava A. Pain Manag Nurs. 2024;25(6):104495. doi:10.1016/j.pmn.2024.08.003.
2. Elzomor A, Tunkel A, Lee E, et al. Am J Otolaryngol. 2022;43(6):103594. doi:10.1016/j.amjoto.2022.103594.
3. Vemulakonda A, et al. J Arthroplasty. 2021;36(9):3113-3118. doi:10.1016/j.arth.2021.03.041.
4. Alowais D, et al. BMC Nurs. 2026;25:287. doi:10.1186/s12912-026-02843-9.

5.4 การจัดการเชิงระบบและองค์กร (System and Organization Management)

1. **การกำหนดนโยบาย** (Policy)



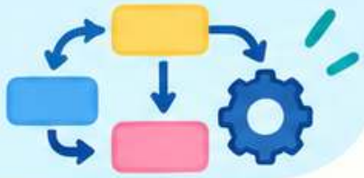
2. **การประเมินความเสี่ยง** (Risk Assessment)



3. **มาตรการควบคุม** (Control Measures)



4. **การจัดระบบงาน** (Work System Systemization)



5. **การอบรมและสมรรถนะ** (Training & Competency)



6. **ระบบรายงาน** (Reporting System)



7. **การดูแล** (Care & Supervision)



8. **การฟื้นฟูและกลับเข้าทำงาน** (Rehabilitation & Return to Work)



9. **การติดตามและปรับปรุง** (Monitoring & Improvement)



5.5 การส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างความตระหนักรู้
Education & Health Promotion



1 การอบรมหลัก Ergonomics
และการฝึกท่ายืดเหยียดที่สามารถทำได้ในห้องผ่าตัด



2 การส่งเสริมการออกกำลังกายเฉพาะกลุ่ม



3 โปรแกรมลดน้ำหนัก



การบริหารยืดเหยียด

เพียง

5

นาที

ทำได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด

Physical exercise

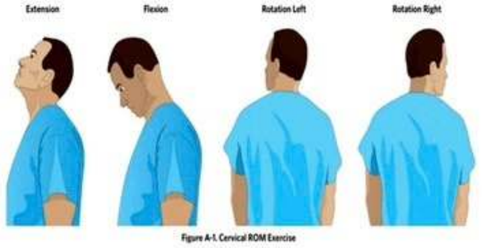
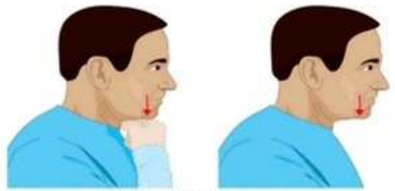


Figure A-1. Cervical ROM Exercise

Fig A-1. Cervical ROM (Ext/Flex/Rot L/R)


Figure A-2. Deep cervical flexor training

© American College of Surgeons 2023. Content may not be reproduced or repurposed without

Fig A-2. Deep cervical flexor training


Figure A-3. Standing Scapular Retraction

Fig A-3. Standing Scapular Retraction


Figure A-4. Upper Trapezius Stretching


Figure A-5. Levator Scapulae Stretching

Fig A-4 & A-5. Upper Trap & Levator Stretch


Figure A-6. Pectoralis Stretching

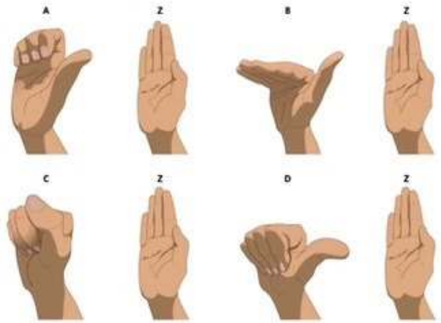


Figure A-9. Lumbrical stretching


Figure A-10. Passive wrist extension with elbow straight


Figure A-11. Median nerve mobilization

QR code
Physical exercise



ประสบการณ์





weight loss

โครงการสุขภาพองค์กร
ลดพุง ลดโรค (ห้องผ่าตัด)

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ BURIRAM HOSPITAL

โดย: โรงพยาบาลบุรีรัมย์

สรุปโครงการ : การเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ขั้นตอนการเริ่มโครงการ

- ลงสมัคร (สมัครเดี่ยว / สมัครทีม)
- คัดกรองสุขภาพ & วิเคราะห์ร่างกาย (InBody): BMI & Body Fat Analysis



ระยะเวลาประเมิน

ระยะเวลาโครงการ 4-6 เดือน

ติดตามความก้าวหน้า (กราฟ ผม. ลด, InBody ดีขึ้น)

ผลลัพธ์ & ประโยชน์

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ไม่ปวดหลัง
- ไม่เจ็บป่วย
- พลังงานเหลือ
- BMI ลด



รางวัลโครงการ



รางวัลสำหรับผู้ชนะ
ประเภทเดี่ยวและประเภททีม

เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ดีกว่า ด้วยสุขภาพพยาบาลห้องผ่าตัดที่แข็งแรงกว่า

เทรพยทบาล BURSPITAL

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค









สรุปภาพกิจกรรม

โครงการ ‘ลดพุง ลดโรค’ ปี 256

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บาหา ลดพุง ลดโรค ลดโลลดนาหาค่กมารแกบจนพจำนายนหนิตถ์สจาเทยนแลดี่ นองแกมนข้ายังมขลานโตสภาพทยบคกถิพการตเมายนาน ล้องกายไม่คำดีขีนาฉีกษนนอเหลือในโกความตอะเทุกนังเม่าน วันที่ 2 กรกฎาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

BURIRAM HOSPITAL NEWS

ฉบับที่ 293 ปีงบประมาณ 2569
ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2569

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ที่มีดัชนีมวลกายเกิน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นำโดย คุณอิสราภาภรณ์ รัตนโภคภัณฑ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา จัดโครงการปรับแปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ที่มีดัชนีมวลกายเกิน ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุขได้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ตามหลัก 3อ. 2ส. สร้างและนำซ่อมสุขภาพ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อลดค่า BMI และรอบเอวที่เกินมาตรฐาน ทั้งยังเป็นผู้นำบุคคลต้นแบบในการปรับแปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค เพื่อเกิดภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารอำนวยการเก่า



โรงพยาบาลบุรีรัมย์ https://brh.moph.go.th
ภาพประกอบข่าว งานโสตทัศนศึกษา
ผลิตผลงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดย งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 4461 5002 ต่อ 2117 -8



แนวทางการจัดการ MSDs อย่างเป็นระบบ

05:00

ฝากถึงเด็กจบใหม่
อย่าขึ้นเวร ทำงานหนัก
ระวังเป็นปวดหลัง ไม่สบาย

ไม่ได้เป็นห่วง แต่เป็นเหมือนกัน

1,096

103

289

37

c_cchaniiiii

ติดตาม

ดูเพิ่มเติม


HOSPITAL
THANK YOU